Machine Translated by Google

德语阿尔茨海默氏症和痴呆症组织 (DADO)

语言指南

“失智”

association luxembourg alzheimer

Dachverband Demenz Selbsthilfe Austria

LIGUE NATIONALE ALZHEIMER LIGA ASBL/VZW/VOG

ASAA 阿尔茨海默症 南蒂罗尔 南蒂罗尔

alzheimer Schweiz Suisse Svizzera

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz

DEMENZ LIECHTENSTEIN

Machine Translated by Google

内容

序言 3

1. 谈论痴呆症时,应该用什么样的语言来表达?
为什么我们需要它们? 3

2. 关注资源
打破刻板印象和迷思 4

3. 询问相关人员 5

4. 语言 6

4.1 谈论痴呆症 6

4.2 谈论痴呆症的症状 6

4.3 关于相关症状
用行为和心理学说话 7

4.4 谈论痴呆症患者 7

4.5 谈论 65 岁以下痴呆症患者 8

4.6 关于家人、朋友、护理人员或护士
谈论痴呆症患者 9

致谢 9

首选术语概述 10

Machine Translated by Google

前言

在讨论痴呆症的话题时，

与患有痴呆症的人交谈时，使用适当的语言非常重要。它的目的不是污名化，而是促进受影响者的理解、包容和参与

并最终为所有相关人员提供高质量的生活。为了更接近这一目标，我们将本指南发送给从事治疗、护理和护理的专业人士、媒体专业人士、公共话语和政治。

德语阿尔茨海默病和痴呆症组织DADO 的成员们一致认为，DEMENTIA 一词可以继续使用，因为它是众所周知、易于理解的，而且自古以来就有历史记载。然而，应该记住的是，这个表达式是一个复杂的整体

症状，并且有几种形式，每种形式都有不同的致病因素。

DEMENTIA 分类也用于欧洲广泛使用的 ICD 10/11（国际疾病分类）。

目前， DSM 5（精神障碍诊断和统计手册)中提出了“神经认知障碍”（NCD)一词，作为“医学术语”取代了“痴呆症”一词，以减少耻辱感，而耻辱感往往会被患者拒绝。尽管如此，“痴呆症”一词仍将被使用。然而，谨慎使用这个熟悉的术语可以避免可能产生的负面含义。

我们希望通过以下信息来支持语言的适当使用。

1. 谈论什么话题比较合适痴呆症，我们为什么需要它？

我们对待痴呆症患者生活的态度是欣赏和尊重。这也应该反映在我们的语言中。痴呆症的诊断仅仅是一般身体和心理状况的一个部分，是一个有其传记的复杂人格的一个部分，永远不能适用于整个人。尊重的语言关注的是人、他们的资源、他们获得的能力、他们的个性以及他们的生活经历和感受，并避免耻辱和歧视。尊重相关人员所偏好的条款非常重要。无论他们是否参与谈话，这都适用。

我们选择的词语对痴呆症患者、他们周围的人和更广泛的社交圈以及广大公众有着至关重要的影响。它们影响一个人的心情、自尊和快乐或抑郁等感觉，也影响其他人对痴呆症的看法。日常对话中的自然性和实事求是有助于持续改善所有相关人员的福祉，并纠正社会上痴呆症患者的形象。

Machine Translated by Google

2. 关注资源

打破刻板印象和迷思

每个痴呆症患者都是独一无二的。此外,痴呆症有多种不同形式,其症状可以通过多种相互作用和个体表现表现出来。我们很少谈论那些仍然存在并将长期存在的技能。

因此你需要了解以下信息:

·获得技能

关注能力而不是损失可以帮助人们保持积极和有意义的活跃并维护自尊。

·课程

重要的是要了解行为的改变是由大脑的变化引起的,并且还会受到个人的社会和物质环境、其他医疗条件和药物等的影响。该过程通常以轻微的限制开始,并可延续数年/数十年,在此期间许多能力至少得到部分保留。

·症状

重要的是要知道“痴呆症”一词描述的是由影响大脑的疾病引起的症状模式。痴呆症会影响思维、沟通、记忆、感觉知觉、情绪、行为和/或应对日常需求的能力。随着时间的推移,它会越来越影响病人的家庭、社交和职业生活。重要的是要清楚地了解,痴呆症是症状的总称,并且痴呆症有很多种类型,每种类型都有其自己的原因。必须将症状(例如,作为对某种情况的疾病相关反应的攻击性行为)与此明确区分开来。

痴呆症对一个人的影响有非常不同的方式。在大多数情况下,

然而,行为或情绪的变化是某些需求或感受(例如沮丧、痛苦、无聊、孤独、困惑、恐惧,还有喜悦或喜爱)的表达,而这些感受是人们无法用语言表达的。

更多详细信息请访问:

网址:www.ala.lu
www.alzheimer-schweiz.ch
www.alzheimer-selbsthilfe.at
www.alzheimer.bz.it
li.demenz.li
www.deutsche-alzheimer.de
www.alzheimer-belgium.be

Machine Translated by Google

3. 询问相关人员

个人和家庭使用对他们有意义且相关的术语和描述来描述他们与痴呆症的经历。但并非所有人都希望自己的经历被以同样的方式描述。如果可能的话,直接询问此人。尊重患者关于使用或不使用某些与痴呆症有关的术语的意愿是维护患者尊严的一部分。

“如果你认识患有痴呆症的人,
这就是你对痴呆症了解的全部了。我们知道
永远不会涉及每个人的一切。而且你肯定不会了解有关痴呆症的一切。 […]

我们都是独特、与众不同的人。而且这种独特的
活动不会因为我们患有痴呆症的症状而简单地消失。 […]
我告诉人们我有残疾,而不是我病了。我告诉他们我患有无法治愈的慢性残疾。我将其与关节炎进行比较,因为这种残疾与痴呆症的症状一样,通常与衰老有关。但如果你告诉你的朋友你患有关节炎,即使是严重的类风湿性关节炎,也不会改变任何人对你作为一个人的看法。但当你告诉别人 即使是你认识和爱的人 你患有痴呆症时

然后你就开始消失在他们的脑海中[...]
我们都需要并且值得拥有人性的需要,我们永远不会失去它。我们需要并且值得对自己感觉良好,活
在当下 而不是活在过去。”

理查德·泰勒教授,2008 年《阿尔茨海默病与我》报告的作者。

2011 年 4 月 15 日法兰克福演讲摘录

Machine Translated by Google

4. 语言

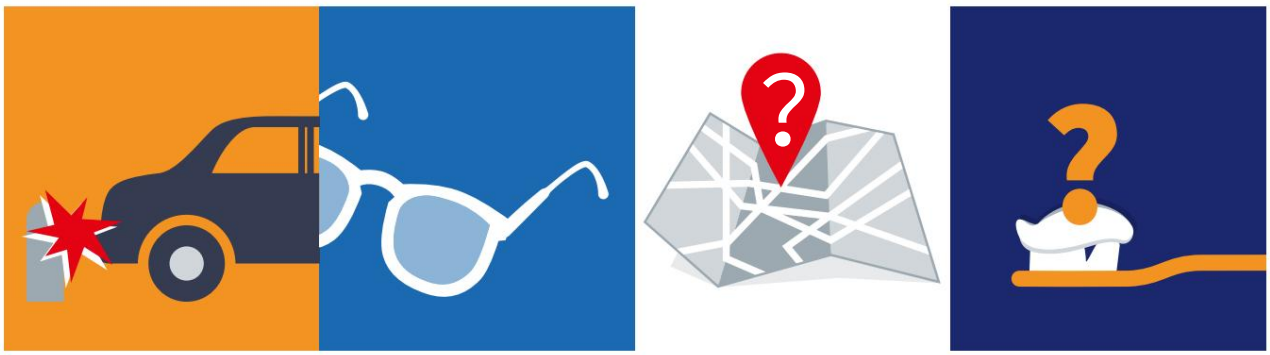
4.1 谈论痴呆症

谈论痴呆症时最好使用以下单词和短语：

- 痴呆症
- 阿尔茨海默病和其他痴呆症
- 痴呆症
- 一种痴呆症
- 一种痴呆症
- 痴呆症的病因　例如，阿尔茨海默病是痴呆症的病因
- 认知障碍

不应使用下列单词和短语：

- 苦难与痛苦
- 老年性痴呆和老年性痴呆
- 痴呆症和老年痴呆症
- 否认
- 痴呆症
- 酸橙



4.2 谈论痴呆症的症状

讨论痴呆症的症状时，最好这样做：

- 描述症状本身，例如记忆问题、情绪或行为变化、难以找到词语、迷失方向、健忘等。
- 描述症状的影响。例如，“沟通困难”这一症状意味着患有痴呆症的人无法再理解某个问题；　“定向困难”导致她再也找不到回家的路等等。

Machine Translated by Google

4.3 谈论与行为和心理相关的症状

在讨论心理和行为时,最好使用以下术语

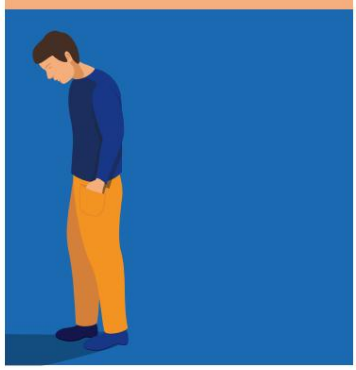
痴呆症的症状:

- 改变行为
- 表达未满足的需求
- 攻击性/不适当的反应（不是行为）（口头、非口头或身体）
- 痴呆症的行为和心理症状（在医学背景下）
- 与痴呆症相关的行为

在讨论心理和行为时,应避免使用以下术语

痴呆症的症状:

- 困难行为
- 攻击性（一般行为,不参考具体情况,也不作进一步描述）
- 问题行为



“挑战性行为”这一术语已在专业痴呆症护理中得到确立。从痴呆症患者的角度来看,某些行为并不是为了挑战而存在的。然而,痴呆症相关行为对于患者周围的人来说可能具有挑战性,尤其是对于亲属和护理人员来说。使用该术语时应牢记这一区别。

4.4 谈论痴呆症患者

谈论痴呆症患者时最好使用以下单词和短语:

- 被诊断患有痴呆症的人
- 患有痴呆症的人
- 患有痴呆症的人
- 患有痴呆症的人
- 患有痴呆症的人
- 在医学背景下:患有痴呆症的人或痴呆症患者
- 有认知障碍的人

Machine Translated by Google

不应使用下列单词和短语：

- 前导*r
- 受害者
- 痴呆症患者
- 疯狂*r
- 病人
- 空壳
- 他或她消失了
- 没有思想/没有灵魂的人
- 囚犯（作为护理机构的居民）
- 患者（非医疗背景）
- 贬义口语表达（“不太对劲”、“古怪”、“脑子有病”、“疯了”、“愚蠢”、“白痴”、“疯狂”……）
- 孩子般的、幼稚的反应，孩子如何成为

为什么？

列出的许多词语都是不尊重、冒犯和贬损的。 “痛苦”和“受害者”等词语加剧了人们对痴呆症患者的歧视。 “痴呆症”是把疾病放在人之前，把人与疾病等同起来。当我们谈到“患有痴呆症的人”或“与痴呆症共存的人”时，我们维护了这些人的尊严，强调他们首先是人，不会根据他们的疾病来评判他们。

4.5 谈论 65 岁以下痴呆症患者

与普遍的看法相反，痴呆症也会影响 65 岁以下的人。

讨论 65 岁以下痴呆症患者时，最好使用以下术语：

- 65 岁以下患有痴呆症的人
- 患有痴呆症的年轻人
- 患有痴呆症的年轻人
- 痴呆症在年轻时出现

不应使用下列单词和短语：

- 早老性痴呆（过时的术语）
- 早期痴呆症（“早期痴呆症”有时用于指 65 岁以下人群的痴呆症。然而，该术语也用于早期痴呆症患者，无论年龄大小。为了避免混淆，65 岁以下的人应被称为早发性痴呆症。）

Machine Translated by Google

4.6 谈论痴呆症患者的家人、朋友、照顾者或照护者

患有痴呆症的人通常更喜欢用“与痴呆症共存”这样的短语来指代自己,而不是他们的亲属。

最好使用以下术语来称呼亲属、看护者和护士:

- 他/她与患有痴呆症的人一起生活。
- 他/她陪伴/照顾/支持患有痴呆症的人。
- 他/她陪伴/照顾/支持被诊断为痴呆症/患有痴呆症的人。

- 并非每个人都想成为护理人员或有爱心的亲属
  被提及。如果可能的话,询问此人是否同意这个条款。

感恩

本指南是许多人共同努力的成果。原始版本由德国阿尔茨海默病协会的 Susanna Saxl 撰写。七个德语阿尔茨海默病和痴呆症组织的代表对此进行了多轮修订。在咨询过程中,痴呆症患者以个人或团体形式被询问有关该指南的问题,例如德国的“与痴呆症共存”咨询委员会、瑞士的“Impuls Alzheimer”工作组和卢森堡的痴呆症患者自助小组。此外,亲属们以及各国专家也提出了建议。

Machine Translated by Google

首选术语概述

以下是不同情况下痴呆症患者所偏好的术语的概述。

谈论痴呆症

首选术语	请勿使用
失智	铅,铅
阿尔茨海默病和其他痴呆症	老年痴呆症
一种痴呆症	衰老
一种痴呆症	疯了,疯了
导致痴呆症的原因	否认
认知障碍	痴呆症相关的变化
	酸橙

痴呆症的症状

首选术语
描述症状本身,例如记忆问题、幻觉、难以找到词语。
描述症状的影响,例如沟通困难。

与行为和心理相关的症状

首选术语	请勿使用
改变行为	有问题的 / 困难的 行为
表达未满足的需求	攻击性（与情况无关的一般行为）
攻击性反应（而非行为）	
痴呆症的行为和心理症状（医学背景下）	

无论年龄大小,处于痴呆症初期的人

首选术语	请勿使用
早期痴呆症患者	早期痴呆
	早期痴呆

Machine Translated by Google

谈论痴呆症患者

首选术语	请勿使用
被诊断患有痴呆症的人	前导*r
痴呆症患者	受害者
患有痴呆症的人	痴呆症患者
痴呆症患者	疯狂*r
患有痴呆症的人	病人
在医学背景下:痴呆症患者 / 痴呆症患者	空壳
有认知障碍的人	他或她消失了
	没有思想/没有精神的人
	囚犯（作为护理机构的居民）
	患者（非医疗背景）
	贬义口语表达（“不太对劲”、“古怪”等）（见上文）

65 岁以下痴呆症患者

首选术语	请勿使用
65 岁以下患有痴呆症的人	早老性痴呆
年轻患者	早期痴呆
患有痴呆症的年轻人	
痴呆症年轻化	

谈论痴呆症患者的家人、朋友、照顾者或照护者

首选术语	请勿使用
他/她与一名患有痴呆症的人住在一起。	患有痴呆症的人
他/她陪伴/照顾/支持患有痴呆症的人。	* 并不是每个人都想被称为看护者。如果可能的话，询问此人是否同意这个条款。
他/她陪伴/照顾/关心/支持被诊断为痴呆症/患有痴呆症的人。	

Machine Translated by Google

“我很欢迎这份指南,因为当我处理自己的局限性时,敏感的语言对我来说很重要。

我认为痴呆症这个词完全不适合描述我迄今为止的病情,我非常希望,尽管它是一个医学术语（健康人可能认为它是合适的）,但这个词会遭遇与“老年痴呆”这个词相同的命运,并从日常语言中消失。

我认为痴呆症这个词带有歧视性,因为它总是是有前缀的。它规模庞大、威力强大,吓坏了很多人。”

欧洲痴呆症患者工作组成员 Angela Pototschnigg

版本说明:

德国阿尔茨海默氏症协会 e.五、
痴呆症自助
凯斯街 41 号
D-10787 柏林
info@deutsche-alzheimer.de
www.deutsche-alzheimer.de

卢森堡阿尔茨海默病协会
23, 罗马路
L-8070 伯特兰奇
信息@alzheimer.lu
网址:www.ala.lu

瑞士阿尔茨海默症
古腾街 3 号
CH-3011 伯尔尼
信息@alz.ch
www.alzheimer-schweiz.ch

奥地利痴呆症自助组织
贝娅特丽克斯街 16/3
A-1030 维也纳
info@demenzselbsthilfe.at
www.demenzselbsthilfeaustria.at

阿尔茨海默氏症 · 南蒂罗尔 · 上阿迪杰
阿尔特曼之家 |格里泽广场 18
I-39100 博尔扎诺
信息@asaa.it
www.alzheimer.bz.it

列支敦士登痴呆症
邮政街 14 号
FL-9494 沙恩
邮箱:kontakt@demenz.li
li.demenz.li

全国阿尔茨海默病联盟 ASBL/vzw/VoG
布罗格尼兹街 46 号
B-1070 布鲁塞尔
nfo@alzheimer-belgium.be
www.alzheimer-belgium.be

布局和图形:
Andrea Böhm,莫斯堡

日期:2020 年 8 月

重印:2025 年 3 月